Patientenuntersuchung

XABCDE · SAMPLERS · OPQRST

DATUM | SZENARIO / FALL | TEAM | BEOBACHTER

Ersteindruck

- [ ] Eigenschutz, Szene sicher, Anzahl Patienten
- [ ] Ersteindruck: kritisch / nicht kritisch
- [ ] Nachforderung (NA, weitere Kräfte) erwogen

X Exsanguination Kritische Blutung

- [ ] Lebensbedrohliche Blutung gesucht und erkannt
- [ ] Blutung gestoppt (Druck, Druckverband, Tourniquet, Hämostyptikum)
- [ ] Tourniquet-Zeit notiert

A Airway Atemweg und HWS

- [ ] Patient spricht / Atemweg frei
- [ ] Mundraum inspiziert (Fremdkörper, Erbrochenes, Blut, Schwellung)
- [ ] Atemgeräusche (Stridor, Gurgeln, Schnarchen)
- [ ] Atemweg gesichert (Absaugen, Esmarch, Guedel/Wendl, SGA, Intubation)
- [ ] HWS bei Traumamechanismus beachtet / immobilisiert

B Breathing Atmung

- [ ] Atemfrequenz, Atemtiefe, Atemarbeit, Hilfsmuskulatur
- [ ] SpO_2 gemessen
- [ ] Thorax inspiziert (symmetrisch, Prellmarken, paradoxe Atmung)
- [ ] Thorax palpiert (Instabilität, Krepitation, Hautemphysem)
- [ ] Auskultation beidseits, ggf. Perkussion
- [ ] Halsvenen und Trachealage beurteilt
- [ ] $etCO_2$ (falls beatmet / verfügbar)
- [ ] Maßnahmen: O_2, Lagerung, assistierte Beatmung, Entlastung

C Circulation Kreislauf

- [ ] Puls zentral / peripher (Frequenz, Rhythmus, Qualität)
- [ ] Rekapillarisierungszeit
- [ ] Haut: Farbe, Temperatur, Feuchtigkeit
- [ ] Blutungsquellen: Thorax, Abdomen, Becken, Oberschenkel, nach außen
- [ ] Abdomen und Becken beurteilt

D Disability Neurologie

- [ ] Bewusstsein: AVPU / GCS
- [ ] Pupillen: Größe, Form, Lichtreaktion, seitengleich
- [ ] Blutzucker gemessen
- [ ] BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time)
- [ ] Motorik und Sensibilität aller Extremitäten

E Exposure Untersuchung und Umfeld

- [ ] Blutdruck gemessen
- [ ] EKG (3-Kanal, 12-Kanal bei Indikation)
- [ ] Zugang i.v. / i.o., Volumen, Medikamente
- [ ] Entkleidet, Bodycheck von Kopf bis Fuß
- [ ] Rücken untersucht (Log-Roll)
- [ ] Körpertemperatur gemessen
- [ ] Wärmeerhalt sichergestellt
- [ ] Umfeld: Medikamente, Geruch, Hinweise, Unfallmechanismus

Abschluss

- [ ] Verdachtsdiagnose formuliert
- [ ] Transportziel und -priorität festgelegt
- [ ] Übergabe strukturiert (z. B. SINNHAFT / SBAR)
- [ ] Dokumentation vollständig

SAMPLERS Anamnese

☐	**S Symptome**	Hauptproblem, Begleitsymptome
☐	**A Allergien**	Medikamente, Lebensmittel, Pflaster, Latex
☐	**M Medikamente**	Dauer- und Bedarfsmedikation, Antikoagulation
☐	**P Patientengeschichte**	Vorerkrankungen, OPs, Klinikaufenthalte
☐	**L Letzte ...**	Mahlzeit, Flüssigkeit, Stuhlgang, Miktion, Menstruation
☐	**E Ereignis**	Was ist passiert? Was wurde zuvor getan?
☐	**R Risikofaktoren**	Rauchen, Alkohol, Drogen, Diabetes, Hypertonie
☐	**S Schwangerschaft**	Möglich? Welche Woche? Komplikationen?

OPQRST Schmerz- und Beschwerdeanamnese

☐	**O Onset**	Beginn: plötzlich oder langsam, wobei?
☐	**P Provocation / Palliation**	Was verstärkt, was lindert?
☐	**Q Quality**	Drückend, stechend, brennend, ziehend, kolikartig
☐	**R Region / Radiation**	Wo genau? Ausstrahlung?
☐	**S Severity**	Stärke NRS 0–10: _____
☐	**T Time**	Seit wann? Dauerhaft oder intermittierend? Schon einmal?

Notizen / Debriefing